ESE Hospital Sintético San Jerónimo

Código de habilitación 230010999903 · HISTORIA CLÍNICA DE HOSPITALIZACIÓN

DATOS DEL PACIENTE

USUARIO: MARGARITA CLAUDIA RUIZ HERNANDEZ DOCUMENTO: CC 25662869 EDAD: 71 años SEXO: FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO: 22-02-1955 PROCEDENCIA: Cereté DIRECCIÓN: Avenida 19 # 20-26

TELÉFONO: 305 409 4542 ASEGURADORA: Salud Total HISTORIA: HC-2026-2925 EPISODIO: ADM-464693

FECHA DE INGRESO: 01-09-2026 09:20 SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN

MOTIVO DE CONSULTA

«No puedo respirar bien y tengo las piernas hinchadas».

ENFERMEDAD ACTUAL

Disnea progresiva de una semana hasta hacerse de reposo, ortopnea de tres almohadas y edema de miembros inferiores. Ganancia de 4 kg en 10 días.

Según refiere su familiar Pedro Wilson Pastrana Medina, el cuadro empeoró en las últimas horas.

ANTECEDENTES

Personales: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hipertensión arterial. Familiares: sin relevancia. Alérgicos: niega.

EXAMEN FÍSICO

TA 160/100 mmHg, FC 104 lpm, FR 26 rpm, SatO2 89 % al aire ambiente, T 36,4 °C. Ingurgitación yugular, crépitos bibasales, edema grado III en miembros inferiores.

ANÁLISIS

Falla cardíaca descompensada con congestión pulmonar y sistémica. Se hospitaliza.

DIAGNÓSTICOS

- Insuficiencia cardíaca congestiva
- Hipertensión esencial

ÓRDENES

- Péptido natriurético, creatinina, electrolitos. Justificación: Confirmar descompensación y vigilar función renal con diurético.
- Radiografía de tórax. Justificación: Evaluar congestión pulmonar y derrame.
- Ecografía abdominal total.

RESULTADOS

- Péptido natriurético tipo B: 1.850 pg/mL. Interpretación: Confirma falla cardíaca descompensada.
- Radiografía de tórax: cardiomegalia y redistribución de flujo. Interpretación: Congestión pulmonar.

PLAN DE MANEJO

- Furosemida 40 mg intravenosa cada 8 horas.
- Oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto.
- Restricción hídrica a 1.200 mL por día y control de peso diario.
- Enalapril 10 mg vía oral cada 12 horas.

EVOLUCIÓN

30-08-2026 19:22 · Día 2: Mejoría de la disnea, diuresis 2.400 mL en 24 horas, peso 2 kg menos. Se continúa diurético intravenoso.

03-09-2026 16:52 · Día 3: Sin ortopnea, SatO2 94 % al aire ambiente, edema grado I. Se pasa furosemida a vía oral.

EPICRISIS

04-09-2026 · Día 4: Egreso con mejoría clínica. Diagnósticos de egreso: insuficiencia cardíaca congestiva descompensada e hipertensión arterial. Plan: furosemida 40 mg vía oral cada 12 horas, enalapril 10 mg cada 12 horas, control por cardiología en 15 días, signos de alarma explicados.

PROFESIONAL

Atendido por: Rosa Lorena Ramos Valencia. Registro médico: RM-49517. Especialidad: Ginecología. Firma: _____

Fecha y hora de la anotación: 01-09-2026 09:20